

I. SUR LA FICHE DE POSTE ET LA CONCORDANCE DES MISSIONS (*Notre Levier le plus solide*)

1. **Au regard de la fiche de poste A0055 de juillet 2020** qui nous qualifie de « conducteurs de patients non médicalisés », peut-on engager un **recours en excès de pouvoir** ou une **action en responsabilité** pour obliger le CHU à réviser cette fiche, sachant que la DRH a elle-même admis par écrit l'existence de « transports complexes médicalisés » et que M. Huet a reconnu le « caractère imparfait du protocole » lors du CR du 27 mai 2026 ?
 2. **La fiche de poste actuelle omet totalement le transport de corps**, alors que le Règlement Intérieur des Chambres Mortuaires (Chapitre 2-2) dispose que « les dépôts de corps sont assurés 24h/24 par le service Ambulances ». Cette omission constitue-t-elle une **faute de l'administration** engageant sa responsabilité, et peut-on la faire constater par un expert ou un inspecteur du travail ?
 3. Le **Décret n° 2021-1825** nous a reclassés en Catégorie B (filrière soignante). Le maintien de notre rattachement à la filière logistique au CHU de Toulouse, alors que d'autres unités du SAMU 31 sont classées en filière soignante, constitue-t-il une **rupture d'égalité de traitement interne** justiciable d'un recours devant le juge administratif ?
-

II. SUR LA NBI DE 10 POINTS (TRANSPORTS FUNÉRAIRES)

4. Le CHU refuse cette NBI au motif que notre activité funéraire est « occasionnelle ». Or, les chiffres 2025 font état de **1660 transports de corps**, dont **1045 en horaires nocturnes et décalés** (avant 8h, après 17h30), en autonomie complète sans personnel de chambre mortuaire. Cette qualification d'« occasionnel » relève-t-elle d'une **déformation manifeste de la réalité** justifiant une action en manquement ?
 5. Le **Règlement Intérieur des Chambres Mortuaires** (page 7, Chapitre 2-2) dispose explicitement que les ambulanciers assurent les dépôts de corps 24h/24. Lors du CR du 27 mai 2026, Mme Roger a elle-même cité ce règlement pour affirmer que les ambulanciers sont « en charge du transport des corps ». Cet aveu de la direction peut-il être utilisé comme **preuve de la mission permanente et structurelle**, rendant l'argument de l'« occasionnalité » juridiquement insoutenable ?
 6. Si le Décret NBI s'avère trop restrictif sur l'exclusivité en chambre mortuaire (cumul transport + toilette + habillage), peut-on exiger du juge la **condamnation du CHU à créer une indemnité forfaitaire locale** sur ses fonds propres, sur le modèle du CHU d'Angers, au motif de l'enrichissement sans cause ou du manquement à l'obligation de sécurité ?
 7. Nous sommes habilités « Transports Funéraires » (prérequis obligatoires de la fiche de poste). Le CHU exige cette habilitation mais refuse la prime correspondante. Cette exigence sans contrepartie financière constitue-t-elle un **détournement de l'esprit des textes** ou une **violation du principe d'équivalence** ?
-

III. SUR L'IFR (INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RISQUE)

8. La DRH refuse l'IFR en isolant le seul secteur UHSI (détenus) à 0,25% du temps de travail, alors que nous réalisons **4033 transports liés aux Urgences** et **3751 transports liés à la Psychiatrie** (souvent sous contrainte), soit **7784 interventions à caractère urgent ou sécuritaire par an**. Cette lecture « en silo » de la DRH constitue-t-elle une **manipulation**

- du périmètre réglementaire** que le juge administratif sanctionnerait ?
9. La **procédure de prise en charge des urgences vitales** (QUA-PR-050, version 4, 19/08/2025) du CHU elle-même prévoit que le « service transport patient » est mobilisé pour les urgences vitales et doit communiquer un bilan clinique au SAMU. Cette intégration dans la chaîne de soins urgents ne prouve-t-elle pas que nous exerçons « dans les structures de médecine d'urgence » au sens de l'article R. 6123-1 du CSP, rendant l'IFR légalement due ?
 10. Le CR du 27 mai 2026 révèle que la direction « s'engage à privilégier les candidatures des ambulanciers pour des créations de postes sur le pôle médecine d'urgence ». Cette reconnaissance implicite de nos compétences urgentistes ne fait-elle pas tomber l'argument selon lequel nous ne serions pas exposés aux risques des urgences ?
 11. Face au juge, comment articuler l'argument selon lequel l'ambulance inter-hospitalière est le **prolongement clinique direct** des services d'urgence, et que le critère des 50% doit s'apprécier sur l'ensemble des secteurs à caractère urgent (Urgences + Psy + UHSI) ?
-

IV. SUR LA NBI DE 20 POINTS (SAMU/SMUR)

12. Nous effectuons des transports « SMUR dégradé » en raison de la pénurie de médecins. Le Décret n° 92-112 exige une affectation permanente aux véhicules SMUR. Cette condition est-elle **juridiquement infranchissable** pour nous, ou peut-on arguer d'une **interprétation extensive** au vu de la réalité opérationnelle (transports complexes réalisés faute de SMUR disponible) ?
 13. Faut-il maintenir cette demande de NBI 20 points dans les conclusions comme **levier d'arbitrage global**, même si sa probabilité isolée est faible, pour démontrer l'enrichissement sans cause et la polyvalence forcée ?
-

V. SUR LA RUPTURE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET LES PRÉCÉDENTS

14. Les **CHU d'Angers et de Tours**, soumis au même statut national de la FPH, ont octroyé la NBI, l'IFR et des indemnités locales à leurs ambulanciers après des mouvements sociaux identiques. Comment transformer ces précédents en **argument juridique contraignant** devant le juge administratif : s'agit-il d'une rupture d'égalité de traitement externe, d'un détournement de l'égalité devant la loi, ou d'un manquement à l'obligation d'appréciation globale des missions ?
 15. Peut-on demander au juge une **injonction de faire** (ou une astreinte) pour contraindre le CHU de Toulouse à aligner sa politique indemnitaire sur celle d'établissements comparables ayant reconnu la même réalité opérationnelle ?
-

VI. SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT

16. Le CHU tire un **profit organisationnel et financier direct** de nos 56 843 transports annuels (2025) en nous imposant des compétences d'urgence et des sujétions funéraires qu'il refuse de rémunérer. Cette situation caractérise-t-elle juridiquement un **enrichissement sans cause** de l'établissement public au détriment de ses agents, et peut-on en demander réparation ?
17. Le CHU nous impose des missions de régulation des transports, de gestion des urgences

vitales, de transport de détenus (734 transports UHSI, dont 623 sous escorte), de patients psychiatriques sous contrainte (3751 transports Psy), sans reconnaissance indemnitaire. Cette exposition aux risques majeurs, documentée par les chiffres 2025, ne constitue-t-elle pas une **faute de l'administration** (manquement à l'obligation de sécurité et à l'équité de traitement) ?

VII. SUR LE CONTENTIEUX ET LA STRATÉGIE PROCÉDURALE

18. Le **CR du 27 mai 2026** est signé sous la responsabilité de Mme Roger (DRH) et contient plusieurs aveux : reconnaissance du caractère « imparfait » du protocole, citation du RI des chambres mortuaires confirmant notre mission, proposition de mobilité vers le pôle urgences. Ce document a-t-il valeur de **reconnaissance de droit** ou de **preuve écrite** suffisante pour faire tomber les arguments de la DRH en cas de litige ?
 19. Le dossier contentieux mentionne que « la voie amiable est épuisée » (rupture de séance le 27 mai). Quel délai avons-nous pour saisir le **Tribunal Administratif de Toulouse** ? Faut-il d'abord saisir le **Défenseur des Droits** ou la **DGS** pour épuiser les voies de recours ?
 20. Peut-on demander en référé une **ordonnance sur requête** pour faire cesser l'application immédiate de la fiche de poste obsolète, ou pour obtenir le paiement provisoire de l'IFR et de la NBI 10 points pendant l'instance ?
 21. Le CHU a menacé de courriers de mise en garde et de procédures disciplinaires à partir du 28 mai (CR du 27 mai). Ces menaces, alors que nous exerçons un droit de retrait/greve sur des sujétions non rémunérées, constituent-elles des **mesures de rétorsion illégales** ? Peut-on les attaquer en référé pour faire cesser cette pression ?
-

VIII. SUR LES PREUVES ET L'AUTHENTICITÉ DES CHIFFRES

22. Les chiffres d'activité 2025 (56 843 transports) proviennent d'un relevé manuscrit. Comment les **authentifier juridiquement** (extraction officielle via le logiciel de régulation des transports) pour que la direction ne puisse pas en contester l'authenticité devant le juge ? Faut-il demander une **mesure d'instruction** (expertise informatique) ou une **commission de vérification** ?
 23. La procédure QUA-PR-050 (urgences vitales) et le RI des chambres mortuaires sont des documents internes du CHU. Leur production par nos soins suffit-elle, ou faut-il les **réquisitionner par voie de justice** pour en garantir la force probante ?
-

IX. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES ET RÉPARATOIRES

24. Au-delà de la reconnaissance statutaire, peut-on réclamer le **paiement rétroactif** de l'IFR et de la NBI 10 points depuis la date d'entrée en vigueur du Décret n° 2022-1658 (ou depuis le reclassement en Catégorie B) ? Quelle est la **prescription applicable** (4 ans pour les créances sur l'État, délai spécifique pour la FPH) ?
25. Peut-on demander des **dommages et intérêts** pour rupture d'égalité de traitement, préjudice

moral lié à la déqualification professionnelle, et préjudice financier du fait du refus de primes ?

X. SUR L'INTERVENTION DE L'ARS OCCITANIE

26. L'ARS Occitanie a-t-elle une **compétence réglementaire** pour contraindre le CHU à appliquer le Décret n° 2022-1658 et à harmoniser l'application des textes sur le territoire régional ? Faut-il saisir l'ARS d'un **recours gracieux** avant le contentieux, et cela suspend-il les délais ?
27. Peut-on demander à l'avocate de solliciter une **mission d'inspection de l'ARS** sur la gestion des ressources humaines au CHU de Toulouse, sur le fondement du non-respect des conditions de travail et de l'équité de traitement ?

XI. HARCÈLEMENT MORAL, INTIMIDATION ET ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX LORS DU MOUVEMENT DE GRÈVE

A. Menaces disciplinaires et mise en garde

28. Lors du CR du 27 mai 2026, Mme Roger a menacé d'envoyer dès le 28 mai des **courriers de mise en garde** à tous les agents dont les équipages seraient responsables d'entraves au service minimum, en citant des faits non individualisés (pneus dégonflés, téléphones déchargés, sortie du parking difficile). Ces menaces de sanctions, proférées collectivement et sans identification préalable des auteurs présumés, constituent-elles une **mesure de rétorsion et d'intimidation** prohibée par le principe constitutionnel de liberté syndicale et l'article L. 1132-1 du Code du travail ? Peut-on en demander l'annulation en référé ?
29. Mme Roger a précisé que « tout comportement d'entrave au service minimum fera l'objet d'un courrier de mise en garde » et M. Huet a ajouté que cela concernerait **les deux agents de l'équipage**, sans distinction entre le conducteur et l'accompagnateur, ni entre le gréviste et le non-gréviste. Cette menace de sanction collective et solidaire, visant à briser le mouvement par la pression psychologique, relève-t-elle du **harcèlement moral institutionnel** ou d'une **faute de l'administration** engageant la responsabilité du CHU ?
30. La direction a affirmé « compter sur la bonne volonté des agents » pour ne pas engager de procédures disciplinaires, tout en maintenant explicitement la menace. Cette **stratégie d'ambiguïté managériale** (menaces voilées sous couvert de clémence) peut-elle être qualifiée de **harcèlement moral par déstabilisation** au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail et prise en compte comme élément aggravant dans notre dossier ?

B. Assignations abusives au service minimum

31. Des agents ont-ils été **assignés à des missions décalables ou non urgentes** (transports programmés entre sites, brancardage de routine, transferts non vitaux) sous prétexte de « service minimum », alors que le service minimum ne doit concerner que la sécurité des personnes et la continuité des soins ? Une assignation à des tâches non justifiées par l'impératif de sécurité constitue-t-elle une **dérive abusive** dénaturant le droit de grève et engageant la responsabilité de l'administration ?
32. M. Huet a indiqué lors du CR que les agents assignés devaient être en poste à 7h et que les premiers transports n'avaient été réalisés qu'à 10h le 26 mai, imputant ce retard aux agents. Si les agents assignés au service minimum ont respecté leurs horaires de prise de poste mais que la direction n'a pas organisé la répartition des missions, peut-on inverser la charge de la preuve pour démontrer que le **dysfonctionnement résulte d'une mauvaise organisation de**

la direction et non d'une entrave des agents ?

C. Pression sur les agents contractuels

33. Des agents **contractuels** (CDD, contrats aidés, intérimaires) ont fait l'objet de **pressions directes** pour les dissuader de faire grève ou les inciter à reprendre le travail (menaces de non-renouvellement, de rupture anticipée, de blacklisting, ou de fin de contrat non justifiée). Ces agissements constituent-ils une **discrimination syndicale** et une **violation du droit de grève** ? Les contractuels de la FPH bénéficient-ils de la même protection que les titulaires ?
34. Faut-il engager des **recours distincts** pour les contractuels (conseil de prud'hommes / juge judiciaire) et comment les articuler avec le contentieux administratif global ? Peut-on demander au juge administratif de condamner le CHU pour **faute de service** ayant causé un préjudice distinct aux contractuels, ou doit-on saisir le juge judiciaire sur le fondement du Code du travail ?

D. Appels sur les numéros privés et atteinte à la vie privée

35. Des membres de la direction ou de l'encadrement ont **contacté les agents sur leurs numéros de téléphone privés** (hors heures de travail, en soirée ou le week-end) pour les convoquer, les presser de reprendre le travail ou les menacer de sanctions. Cette utilisation de coordonnées personnelles à des fins de gestion de conflit social constitue-t-elle une **atteinte au droit au respect de la vie privée** (article 9 du Code civil) et une **violation du RGPD** (utilisation abusive de données personnelles à des fins non prévues dans la politique de confidentialité du CHU) ?
36. Le CHU peut-il légalement exploiter les numéros personnels des agents figurant dans le dossier RH pour les contacter en dehors du cadre professionnel et à des fins disciplinaires ? Faut-il saisir la **CNIL** d'une plainte et demander au juge une **injonction de faire cesser ces pratiques** ?
37. Comment **constituer la preuve** de ces appels et de cette intrusion ? Les relevés d'appels, les captures d'écran de messages, les témoignages écrits d'agents ou les enregistrements légaux (avec consentement d'une partie) ont-ils valeur probante devant le juge administratif et/ou le juge judiciaire ?

E. Stratégie procédurale sur ces atteintes

38. Peut-on demander en référé une **ordonnance de protection** ou une **astreinte** pour interdire au CHU :
- de contacter les agents sur leurs numéros privés à des fins de pression syndicale ;
 - de prononcer des mises en garde ou des sanctions disciplinaires sans fondement préalablement établi et individualisé ;
 - de maintenir des assignations au service minimum non strictement justifiées par la sécurité des personnes ?
39. Les courriers de mise en garde effectivement envoyés après le 28 mai (si vous en avez reçu) peuvent-ils être **annulés par le juge** pour excès de pouvoir, au motif qu'ils constituent des sanctions déguisées frappant l'exercice normal d'un droit constitutionnel ? Peut-on en parallèle réclamer des **dommages et intérêts** pour préjudice moral et anxiété générée ?